HELP_Organi_P19 — Groupe D — Lots 237 à 241 — 19 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 19 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

D-064 — Moyenne — LOT 240 · SSP O7.18

Emplacement : LOT_240_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc DX.6 › points 2, 7, 9 (tableaux calcémie, calciurie, PAL, créatininémie), 11.B (adaptation hépatique) et 11.C (intervalles de contrôle) ; fenêtres « ostéopénie », « maladie systémique pertinente »

Contexte : Le cours cite la Liste des analyses (lue via des laboratoires) et la CFN : liste des groupes à « risque très élevé » (tableau 2), valeurs de référence suisses, seuil de densité de l'ostéopénie, intervalle de contrôle et adaptation hépatique non trouvés ; signes de l'ostéomalacie tirés d'une série tunisienne.

Question : Quel est le texte officiel actuel de la Liste des analyses (OFSP, annexe 3 OPAS) pour le dosage de la 25(OH)D (indications limitatives, fréquence) ? Quels groupes à « risque très élevé » liste le tableau 2 du rapport CFN sur la vitamine D ? Quels intervalles de contrôle de la calcémie et de la calciurie sous vitamine D à forte dose (FI suisse) ? Quelle source européenne décrit l'ostéomalacie de l'adulte ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-065 — Moyenne — LOT 240 · SSP O7.18

Emplacement : LOT_240_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc DX.7 › fenêtre « RCRI », tableau « Laboratoire de routine », point 9.c (grossesse, enfant, DFGe) et point 2

Contexte : Le cours écrit : items et points du RCRI, valeurs de référence du laboratoire préopératoire, conduites grossesse/enfant/DFGe et fréquence suisse des bilans de routine non trouvés.

Question : Quels items et points du score RCRI (Lee) reprend l'ESC 2022 ? Quels examens de routine sont déconseillés (Smarter Medicine anesthésiologie, SSAPM) chez le patient ASA I–II, et quelles exceptions (grossesse, enfant, DFGe < 30) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-066 — Moyenne — LOT 240 · SSP O7.18

Emplacement : LOT_240_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.8 › fenêtres « céphalée non aiguë », « niveaux de preuve IV et IIb », « Céphalée positionnelle », « détail de ces situations »

Contexte : Le cours cite la Liste Top 5 de la Société suisse des céphalées (2026) : durée de la céphalée « non aiguë », échelle des niveaux de preuve et conduite en grossesse/enfant non trouvées.

Question : Quel est le texte intégral de la Liste Top 5 de la Société suisse des céphalées (2026) et de ses recommandations thérapeutiques : définition de la céphalée non aiguë, drapeaux rouges (SNNOOP10), échelle des niveaux de preuve, conduite d'imagerie chez la femme enceinte et l'enfant ? Quelle position de l'EHF/EAN la plus récente ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-069 — Moyenne — LOT 240 · SSP O7.18

Emplacement : LOT_240_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › A › Bloc 1 › points 2 et 13 ; P1–P4 › point 2 de chaque DX (fréquence suisse des demandes)

Contexte : Le cours cite 19 indicateurs suisses de faible valeur (2018–2023, > 600 millions CHF) ; mortalité attribuable, définition chiffrée de l'économicité (LAMal art. 32) et fréquences suisses des demandes (antibiotiques, imagerie lombaire, céphalée, PSA, vitamine D) non trouvées.

Question : Quelles données suisses (OFSP, Obsan, Helsana/CSS, LUCID, Smarter Medicine) chiffrent la fréquence des prestations à faible valeur par scénario (antibiotiques pour IVRS, imagerie lombaire précoce, imagerie des céphalées, PSA après 75 ans, dosage de la vitamine D) ? Comment l'OFSP opérationnalise-t-il le critère d'économicité (EAE, LAMal art. 32) depuis le 1.1.2026 ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :

4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-070 — Haute — LOT 241 · SSP O7.19

Emplacement : LOT_241_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › A › Bloc 1 › prévention secondaire (SMA) ; P1 › DX.1 › point 2

Contexte : Le cours écrit : projet pilote national de dépistage néonatal de la SMA approuvé le 20.12.2023 (source associative SMA NBS Alliance) ; confirmation OFSP non trouvée (neoscreening.ch en 503).

Question : La SMA fait-elle partie du dépistage néonatal suisse (programme du laboratoire de Zurich, neoscreening.ch) ? Depuis quelle date, sur quelle décision (OFSP, Commission fédérale) et avec quel test ? Donner la source officielle.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-071 — Haute — LOT 241 · SSP O7.19

Emplacement : LOT_241_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc DX.1 › tableau « Types de SMA et éligibilité » ; point 11.B › fiches Zolgensma®, Spinraza™, Evrysdi®, prednisolone

Contexte : Le cours donne les doses FI de Zolgensma® et Spinraza™ ; adaptation rénale (Zolgensma®, Spinraza™, Evrysdi®), dose d'Evrysdi® selon l'âge et le poids, contre-indications et interactions d'Evrysdi®, description des types 0 à 4 et forme pédiatrique liquide de prednisolone en Suisse non trouvées.

Question : Selon les FI suisses de Zolgensma®, Spinraza™ et Evrysdi® : quelles adaptations rénales et hépatiques, quelles doses d'Evrysdi® selon l'âge et le poids, quelles contre-indications et interactions ? Une forme liquide pédiatrique de prednisolone (ou prednisone) est-elle autorisée en Suisse pour la prophylaxie sous Zolgensma® ? Quelle classification des types 0 à 4 retient le consensus européen (TREAT-NMD/EAN) ? Donner les doses, voies, adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch), avec la date de la FI.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-074 — Haute — LOT 241 · SSP O7.19

Emplacement : LOT_241_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc DX.6 › point 11.B › tableau des médicaments (fludarabine + cyclophosphamide, cytarabine + étoposide, Kymriah®, prémédication, dexaméthasone/méthylprednisolone, lévétiracétam, allopurinol) ; A › fiches tocilizumab, corticoïdes, lymphodéplétion ; P2 › DX.5 fiche tocilizumab

Contexte : Le cours donne les schémas FI de lymphodéplétion ; spécialités suisses de fludarabine, cyclophosphamide, dexaméthasone, lévétiracétam et allopurinol « non vérifiées » ; adaptation de la

lymphodéplétion au DFGe < 30, adaptation rénale et hépatique du tocilizumab et des corticoïdes non trouvées.

Question : Quelles spécialités suisses (FI) existent pour la fludarabine IV, le cyclophosphamide (Endoxan®), la dexaméthasone IV, la méthylprednisolone, le lévétiracétam IV et l'allopurinol ? Quelle adaptation de la fludarabine et du cyclophosphamide en insuffisance rénale (DFGe < 30, 30–70 mL/min) ? Quelles adaptations rénale et hépatique pour le tocilizumab (Actemra®) dans le syndrome de libération de cytokines ? Quelles doses de dexaméthasone par grade de SLC/ICANS (consensus EBMT 2022) ? Donner les doses, voies, adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch), avec la date de la FI.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-076 — Haute — LOT 241 · SSP O7.19

Emplacement : LOT_241_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › A › piège « autorisation étrangère pour la catégorie B » ; P3 › DX.7 › fenêtres « Importation privée de médicaments » et « Remboursement hors liste des spécialités »

Contexte : Le cours écrit : la LPTh art. 49 / OAMéd exigent une autorisation dans un pays à contrôle équivalent ; liste de ces pays non lue (Elevidys autorisé par la FDA, refusé par l'EMA).

Question : Quels pays Swissmedic reconnaît-il comme ayant un contrôle des médicaments équivalent (OAMéd art. 49, LPTh art. 13, OAMal art. 71b) ? Elevidys (délandistrogène moxéparvovec) a-t-il un statut en Suisse (autorisation, importation, remboursement au cas par cas) en 2026 ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-077 — Haute — LOT 241 · SSP O7.19

Emplacement : LOT_241_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc DX.3 › points 2, 9.c et 11.B › fiches hydroxyurée, busulfan IV, plérixafor ± G-CSF ; A › fiches busulfan et plérixafor

Contexte : Le cours écrit : prévalence suisse de la drépanocytose non trouvée (donnée italienne) ; spécialités suisses du busulfan IV et du G-CSF non trouvées ; durée et adaptation hépatique de l'hydroxyurée, adaptation rénale/hépatique du busulfan, seuils d'arrêt pour toxicité et données de grossesse sous Casgevy® non trouvés.

Question : Quelle est la prévalence de la drépanocytose en Suisse (OFS, registre, dépistage néonatal) ? Quelles spécialités suisses existent pour le busulfan IV (Busilvex®), le plérixafor (Mozobil®) et le G-CSF, avec doses et adaptations (FI) ? Quelles doses, titration, durée et adaptation hépatique de l'hydroxyurée (Siklos®) donnent la FI suisse et la recommandation européenne (EHA/SSH Hématologie) ? Donner les doses, voies, adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch), avec la date de la FI.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-085 — Haute — LOT 241 · SSP O7.19

Emplacement : LOT_241_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › A › Bloc 1 › piège « Ignorer le faux positif du VIH » (vecteur lentiviral)

Contexte : Le cours écrit : un test d'amplification VIH peut se positiver après un vecteur lentiviral ; méthode confirmatoire précise non trouvée [S4].

Question : Après un produit à vecteur lentiviral (CAR-T Kymriah®, Carvykti®, Abecma®), quel test confirme ou exclut une infection par le VIH selon la FI suisse et l'OFSP/SSI (test d'anticorps, PCR ciblant une région absente du vecteur) ? Quelle conséquence pour le don de sang et le dépistage ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-072 — Moyenne — LOT 241 · SSP O7.19

Emplacement : LOT_241_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc DX.2 › points 2, 11.C (calendrier postopératoire, OCT) ; A › fenêtre Luxturna® et tableau Bloc 2

Contexte : Le cours écrit : calendrier du suivi ophtalmologique après Luxturna® (J1, J7, M1…) et nombre de patients traités en Suisse non trouvés.

Question : Quel calendrier de suivi ophtalmologique après Luxturna® (voretigène néparvovec) prévoient la FI suisse et les centres européens (registre PERCEIVE) ? Combien de patients ont été traités en Suisse (Swissmedic, centres universitaires) ? Quelles contre-indications et quelle spécialité suisse de prednisone pour la prophylaxie de Luxturna® ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-075 — Moyenne — LOT 241 · SSP O7.19

Emplacement : LOT_241_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › A › pièges « CAR-T, Casgevy®, Qalsody™ hors LS » ; P2 › DX.5 › piège « annexe 1 OPAS / LS »

Contexte : Le cours écrit : prix des CAR-T non publics (tarif assureurs–hôpitaux) ; Casgevy® et Qalsody™ absents de la LS.

Question : Quel est le statut actuel (2026) de remboursement des CAR-T (annexe 1 OPAS, forfaits SwissDRG) et de Casgevy®, Qalsody™, Hemgenix® (LS, OAMal art. 71a–d) ? Des prix ou forfaits sont-ils publiés (SwissDRG, OFSP) ? Combien de patients ont été traités en Suisse par Luxturna®, Casgevy®, Hemgenix®, Carvykti® et Abecma® depuis leur autorisation ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-078 — Moyenne — LOT 241 · SSP O7.19

Emplacement : LOT_241_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc DX.4 › point 9.c et 11.B › fiches Idelvion® et Hemgenix® ; P3 › DX.7 › surveillance hépatique après AAV systémique

Contexte : Le cours écrit : durée, adaptation rénale ou hépatique et contre-indications de la prophylaxie Idelvion® non trouvées ; adaptation rénale d'Hemgenix® non trouvée ; conduite chez la femme non trouvée ; formulation de la FI de Zolgensma® sur la surveillance hépatique jugée ambiguë.

Question : Selon les FI suisses d'Idelvion® et d'Hemgenix® : contre-indications, adaptations rénale et hépatique, conduite chez la femme porteuse ; quel calendrier exact de surveillance hépatique (ALAT, facteur IX) après Hemgenix® et après Zolgensma® ? Donner les doses, voies, adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch), avec la date de la FI.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-079 — Moyenne — LOT 241 · SSP O7.19

Emplacement : LOT_241_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc DX.6 › point 2 (incidence LAL-B), point 7 (syndrome de lyse tumorale), point 9 (CD19, fibrinogène) ; P2 › DX.5 fenêtre « LDH et IPI » ; A › fenêtre « Ce qui distingue DX.6 »

Contexte : Le cours écrit : incidence suisse, facteurs de risque et mortalité de la LAL-B, sémiologie européenne de la LAL de l'enfant, seuils biologiques du syndrome de lyse tumorale, seuil du fibrinogène, seuil de positivité CD19 et classes de risque de l'IPI non trouvés.

Question : Quelle est l'incidence suisse de la LAL de l'enfant et de l'adulte jeune (Registre suisse du cancer de l'enfant, NICER) ? Quels critères biologiques du syndrome de lyse tumorale (Cairo-Bishop) et quel seuil de fibrinogène retiennent les consensus européens ? Quelles classes de risque de l'IPI (0–5 points) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-080 — Moyenne — LOT 241 · SSP O7.19

Emplacement : LOT_241_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc DX.7 › points 2, 6, 7, 9, 11.B (prednisone/deflazacort, sirolimus) et 12 (prévention)

Contexte : Le cours écrit : prévalence suisse, mortalité, distinction Duchenne/Becker, mécanisme neurocognitif non trouvés ; deflazacort sans spécialité dans l'AIPS au 21.10.2026 ; posologies tirées d'un consensus CDC/TREAT-NMD (non suisse) ; Prednisone Streuli® sans indication DMD.

Question : Quelle est la prévalence de la dystrophie musculaire de Duchenne en Suisse (registre suisse des maladies neuromusculaires) ? Le deflazacort, le vamorolone (Agamree®) ou le givinostat sont-ils autorisés par Swissmedic en 2026 ? Quelle corticothérapie (dose, schéma) recommande le consensus européen le plus récent (TREAT-NMD/EAN 2024) ? Quels critères distinguent Duchenne et Becker ? Quel protocole (éculizumab, rituximab + sirolimus) pour la microangiopathie thrombotique après AAV systémique, et l'AI couvre-t-elle la DMD après 20 ans ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-081 — Moyenne — LOT 241 · SSP O7.19

Emplacement : LOT_241_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.8 › points 2, 9 (biopsie, test de marche, vitamine A) et 11 (transplantation, assistance ventriculaire) ; fenêtre « PND, NIS, Karnofsky, NYHA »

Contexte : Le cours lit le consensus suisse ATTR 2021 en résumé ; prévalence suisse, classes PND détaillées, valeurs de référence du test de marche et de la vitamine A, rôle de la transplantation non trouvés ; seuils LS (≥ 150 m Amvuttra®, > 100 m Vyndaqel®).

Question : Que recommande le texte intégral du consensus suisse sur l'amylose ATTR (Swiss Amyloidosis Network, 2021, et mise à jour) et la guideline ESC 2021/2023 (cardiomyopathies) : critères diagnostiques non invasifs, classes PND, place du tafamidis, du vutrisiran, de l'acoramidis et de la transplantation ? Quelles limitations actuelles de la LS ? Quelle prévalence suisse ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-082 — Moyenne — LOT 241 · SSP O7.19

Emplacement : LOT_241_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.9 › fenêtres « Responsabilité du promoteur (LRH art. 19–20) », « Quelle phase ? » ; P3 › DX.6 › sources (directive ASSM CAR-T) ; A › fenêtre « répond » (directive ASSM thérapie standard/expérimentale)

Contexte : Le cours écrit : détails de la preuve du lien causal (LRH), définition détaillée des phases et directive ASSM propre au CAR-T non trouvés ; l'ASSM ne publie aucune directive propre à la thérapie génique.

Question : Que dit la directive ASSM « Distinction entre thérapie standard et thérapie expérimentale » (année, URL) applicable à la thérapie génique et aux CAR-T ? Quelles définitions des phases I à IV donnent l'OClin et l'ICH E8(R1) ? Comment l'ORH/OClin règlent-ils la responsabilité du promoteur et la preuve du lien de causalité ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-083 — Moyenne — LOT 241 · SSP O7.19

Emplacement : LOT_241_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.10 › exemple « site suisse promettant la guérison », point 2 (fréquence), fenêtre « Constitution fédérale art. 119 et LPMA art. 35 »

Contexte : Le cours écrit : procédure formelle de signalement d'une publicité illicite à Swissmedic, fréquence des demandes sur des thérapies non prouvées et options légales de la procréation non trouvées.

Question : Quelle procédure Swissmedic prévoit-elle pour signaler une publicité illicite ou une offre de thérapie cellulaire/génique non autorisée (formulaire, base LPTh art. 32 et 86) ? Quelles options légales de procréation (diagnostic préimplantatoire, LPMA art. 5a) proposer à un couple porteur ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-084 — Moyenne — LOT 241 · SSP O7.19

Emplacement : LOT_241_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc DX.1 et DX.2 › point 9 (tests génétiques SMN1/SMN2, RPE65) ; A › fenêtre « analyse génétique confirmatoire » ; P3 › DX.7 tableau « test génétique du gène DMD »

Contexte : Le cours écrit : sensibilité et spécificité des tests génétiques SMN1, RPE65 et DMD non trouvées ; cadre LAGH documenté.

Question : Quelles sensibilité et spécificité (ou taux de détection) des analyses génétiques SMN1 (délétion exon 7, MLPA/qPCR), RPE65 (séquençage) et DMD (MLPA + séquençage) publient les guides de bonnes pratiques européens (EMQN, EuroGentest) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P19 — 19 questions : D-064, D-065, D-066, D-069, D-070, D-071, D-074, D-076, D-077, D-085, D-072, D-075, D-078, D-079, D-080, D-081, D-082, D-083, D-084